

41 - FMPM MOOCs - Semiologie - ORL - Pr. Raji

Dans le cadre des cours de sémiologie en relation avec l'appareil auditif, nous avons déjà vu les surdités, nous allons traiter maintenant un certain nombre de symptômes qui peuvent accompagner la surdité, en particulier les autalgies. Les objectifs de ce cours sont tout d'abord, comment définir une autalgie, deuxièmement savoir mener un examen, une anamnèse devant une autalgie. Troisièmement, savoir mener un examen clinique devant une autalgie, comment différencier entre autodynies et autalgie réflexe, et enfin citer les différentes étiologies des autodynies et des autalgies réflexes.

Alors, c'est quoi une autalgie? Par définition, c'est une douleur tout simplement ressentie au niveau de l'oreille. Ces étiologies sont diverses. Ça peut être des lésions au niveau de l'oreille ou une lésion au niveau de la sphère ORL avec un examen de l'oreille tout à fait normal.

C'est ce qui nous permet d'emblée de différencier entre autodynies où l'autalgie est associée à une lésion au niveau de l'oreille et une autalgie réflexe où l'autalgie s'accompagne avec un examen de l'oreille tout à fait normal. Et à ce moment là, le plus souvent, la lésion siège au niveau de la sphère ORL. Pour traiter ce cours, nous avons déjà parlé de l'introduction.

Nous allons traiter les données anamnestiques devant une autalgie. Comment mener un examen clinique d'une autalgie? Et quels sont les étiologies des autalgies? L'anamnèse d'un patient présentant une autalgie doit s'acquies de son âge et de son sexe. Parce qu'une autalgie chez un enfant a des étiologies bien particulières par rapport à l'autalgie chez l'adulte.

Les antécédents, plus particulièrement les antécédents autologiques d'otites moyennes chroniques, qui peut justifier la réapparition de la douleur lors d'une surinfection. La présence d'une maladie de la sphère ORL, plus particulièrement la maladie néoplasique au niveau du larynx ou du pharynx qui sont déjà traités. Et les antécédents généraux du patient, en particulier l'existence ou non d'un diabète chez le patient.

Est ce que le patient présente des habitudes et des intoxications, plus particulièrement les intoxications tabagiques et alcooliques? Et l'usage de coton-tige pour le nettoyage des conduits auditifs externes. Ensuite, on va s'intéresser à la douleur ou symptômes d'autalgie. Pour rechercher les circonstances d'apparition, leur intensité, leur type, leur ancienneté.

Leur unilatéralité ou bilatéralité et leur évolution dans le temps. Est ce que c'est une autalgie qui est apparue et s'aggrave dans le temps? C'est une autalgie qui est apparue et qui est en train de diminuer ou bien qui est récidivante? Et bien sûr, en fonction des différentes situations, on a des étiologies particulières. Mais le plus important sur le plan anamnestique, c'est la recherche des signes accompagnateurs, plus particulièrement l'existence d'un prurite auriculaire.

Justifiant un grattage au niveau de l'oreille, des otorrhées, une hypoacousie ou une surdité. Des acouphènes, des vertiges et des signes accompagnateurs en dehors de l'appareil auditif, plus

particulièrement en rapport avec une dysphagie, une dysphonie et l'existence d'un syndrome fébrile. Tous ces signes accompagnateurs vont nous orienter d'emblée sur l'appareil où pourrait exister une anomalie.

Et bien sûr, qui va nous permettre de distinguer entre autodynies et entre autalgies réflexes. L'examen clinique du patient sera focalisé sur l'examen otologique avec l'examen du pavillon de l'oreille qui peut être tout à fait normal. Nous avons mis là une photo d'une situation anormale avec la présence déjà de l'explication de l'autalgie par la présence d'une tumefaction hématique.

C'est ce qu'on appelle l'othématome du pavillon de l'oreille. Un examen otoscopique qui va permettre de visualiser le conduit auditif externe et la membrane tympanique et qui va nous permettre de juger de leur normalité ou de leur pathologie. Expliquons l'otalgie.

L'examen clinique doit s'intéresser par la suite à l'examen de la cavité buccale et du pharynx à la recherche d'une lésion justifiant une douleur projetée au niveau de l'oreille. Le cadre des autalgies réflexes. Un examen de l'hypopharynx et du larynx par la laryngoscopie indirecte.

Comme vous voyez sur cette photo du bas où le médecin peut visualiser grâce au miroir laryngé, les cordes vocales, le larynx, la margine laryngée. Bien sûr, l'hypopharynx pour voir est ce qu'il y a une lésion justifiant cette otalgie. L'examen du cavum qui pourrait se faire par la nasophibroscope à travers les fosses nasales et à travers les courants.

On peut aller rejoindre et examiner le cavum qui va nous permettre d'avoir une idée de l'existence ou pas d'une lésion. L'examen de l'articulé dentaire. Qui, en cas d'anomalie, peut nous expliquer l'existence de douleurs au niveau des articulations temporomandibulaires.

Dans le cadre du syndrome algodystrophique des ATM et on terminera par l'examen des percraniennes, en particulier de la cinquième, septième, neuvième et dixième percranienne. Les étiologies des otalgies vont nous permettre de différencier en deux grandes situations, à savoir les otalgies primitives. Ce qu'on appelle aussi les otodynies.

Dans ce cadre là, l'otalgie est associée à une lésion au niveau de l'oreille, plus particulièrement au niveau du pavillon de l'oreille ou au niveau du conduit auditif externe ou au niveau de l'oreille moyenne. Au niveau du pavillon de l'oreille, la lésion peut être d'origine traumatique, à savoir par exemple la présence d'un otématome, d'origine infectieuse telle que la péricondrite du pavillon de l'oreille ou une lésion tumorale, qu'elle soit bénigne ou maligne. Le conduit auditif externe peut être aussi le siège de lésions dans le cadre des otodynies.

Ces lésions peuvent être traumatiques, par l'usage de cotons-tiges, par exemple, infectieuses dans le cadre des otites externes, qu'elles soient simples ou malignes ou nécrosantes, par la présence aussi d'un furoncle du conduit auditif externe ou d'un zona de la région de Ramsey-Hind. Vous voyez sur cette photo du haut, vous avez une otite externe avec une inflammation de la région de Ramsey-Hind, bien sûr, pouvant faire évoquer un zona. Ou secondaire à une lésion

tumorale du conduit auditif externe, vous comprenez très bien qu'avec l'examen otoscopique, on peut visualiser l'étiologie de cette otalgie dans le cadre de l'otodynie.

Les lésions de l'oreille moyenne qui peuvent expliquer une otodynie peuvent être d'origine infectieuse, telles que les otites moyennes aiguës. Par exemple, ici, vous voyez une otite moyenne aiguë ou congestive avec une inflammation au niveau du manche, du marteau et du shrapnel, ou une otite moyenne chronique en phase de réchauffement par surinfection. D'origine traumatique telle que les perforations tympaniques post-traumatiques, au cours duquel on retrouve une perforation à bord rectiligne avec un nématome de la membrane tympanique.

Et la possibilité relativement rare des tumeurs de la caisse du tympan qui peuvent justifier cette otodynie. Les deuxième étiologies des otalgies sont représentées par les otalgies réflexes, au cours duquel l'examen otoscopique et l'examen du pavillon sont tout à fait normal. La cause de ces otalgies réflexes peuvent se situer au niveau de la cavité buccale, au niveau duquel on peut retrouver une carie dentaire.

Ou une lésion de la langue, plus particulièrement un cancer de la langue qui peut se manifester comme premier symptôme par une otalgie réflexe. Des lésions au niveau du larynx, plus particulièrement une inflammation des amygdales palatines suite à une angine. Ou une tumeur de cet amygdale palatine relatant d'une otalgie réflexe unilatérale.

Une lésion de l'hypopharynx du larynx recherchant une tumeur maligne, comme vous voyez sur cette photo du bas, où on voit au niveau de la marge laryngée l'existence d'une lésion tumorale étendue au sinus péricarinaire. Le premier symptôme dans ce cadre là, ça peut être une otalgie réflexe avec parfois un accrochage alimentaire. Au niveau du cavum, on recherchera comme étiologie de ces otalgies réflexes une tumeur.

Le plus souvent, il s'agira d'une tumeur maligne. Et au niveau de l'articulation temporomandibulaire, le syndrome algodystrophique de l'ATM donnant un craquement au niveau de l'articulation temporomandibulaire peut être à l'origine d'otalgie réflexe avec des douleurs projetées au niveau de l'oreille. Le rachis cervical peut être une cause d'une otalgie réflexe dans le cadre du rachis arthrosique, où la compression du nerf d'Arnold peut être secondaire à une névralgie d'Arnold.

Et enfin, les différentes névralgies faciales peuvent être à l'origine de douleurs projetées au niveau de l'oreille, justifiant d'une otalgie réflexe. En conclusion, devant une otalgie, vous concevez très bien qu'avec les données anamnestiques et l'examen clinique centré sur l'otoscopie et l'examen de toute la sphère ORL, va nous permettre de différencier entre les deux grandes situations, otodynie et otalgie réflexe. Otodynie, où l'appareil auditif présente une lésion, ou dans le cadre de l'otalgie réflexe où l'appareil auditif ou l'otoscopie est tout à fait normal, le pavillon est normal.

Et une fois que nous aurons différencié entre les deux situations, on pourra à ce moment là se

pencher sur les étiologies qui vont être dans le cadre de l'otodynne essentiellement représentées par des lésions du pavillon, du conduit ou de l'oreille moyenne. Et dans le cadre des otalgies réflexes, toutes les lésions de la sphère ORL et plus particulièrement de la cavité buccale, de l'oropharynx, de l'hypopharynx, larynx, du cavum, mais aussi de l'articulation temporomandibulaire ou du rachis cervical et qui peuvent justifier d'une douleur projetée au niveau de l'oreille. Je vous remercie.

Bonjour, après avoir vu les. Les surdités et les otalgies, nous allons s'intéresser à un cours en relation avec les otorées qui va nous permettre de définir ses objectifs. Tout d'abord, comment définir une otorée? Deuxièmement, savoir mener une anamnèse devant une otorée.

Troisièmement, savoir mener un examen clinique devant une otorée. Et quatrièmement, citer les différentes étiologies des otorées. C'est quoi la définition d'une otorée? C'est tout simplement l'issue du liquide par le conduit auditif externe.

Vous le voyez sur cette photo où le conduit auditif externe laisse couler un liquide qui peut être de nature différente en fonction des situations. Pour traiter ce cours, après l'introduction, nous allons nous intéresser aux données anamnestiques d'une otorée. L'examen clinique d'une otorée.

Et enfin, on va citer un certain nombre d'étiologies des otorées. L'anamnèse s'intéressera plus particulièrement à l'âge et du sexe du patient. Deuxièmement, aux antécédents du patient en particulier, l'existence d'une otite moyenne aiguë récidivant, justifiant un épisode otitique récent.

Et qui expliquait l'existence d'un écoulement par rupture de la membrane tympanique. Une notion de mise en place d'aérateur transtympanique, justifiant une surinfection. Une chirurgie de l'oreille moyenne, plus particulièrement une chirurgie d'une otite moyenne chronique simple ou cholestéatomateuse.

Et bien sûr, les habitudes d'usage du coton tige. Le caractère de l'otorée doit être précisé. Est ce que sa nature est serreuse, muqueuse, purulente ou sanglante? Son abondance.

Est ce qu'elle est minime ou très importante? Son odeur, est ce qu'elle est fade ou fétide? Parce que lorsqu'il s'agira d'une otorée fétide, il pourrait nous faire orienter vers le diagnostic d'otite cholestéatomateuse. Son ancienneté, est ce qu'elle est récente ou est ce qu'elle est très ancienne? Sa permanence, est ce qu'elle est récidivante dans le temps? Son unilatéralité ou bilatéralité? Et surtout ses circonstances déclenchantes, est ce qu'elle est spontanée ou est ce qu'elle est provoquée? Et dans le cadre des otorées provoquées, on recherchera la notion de baignade ou de traumatisme du conduit auditif externe ou de l'oreille moyenne. On s'intéressera aussi à la recherche de signes accompagnateurs, plus particulièrement le prurite auriculaire, les otalgies, les hypoacusies, les acouphènes et les vertiges.

La présence ou pas d'un syndrome fibrile. Et la présence d'une paralysie faciale périphérique

pouvant bien sûr nous orienter dans un certain nombre de situations vers des étiologies bien particulières. L'examen clinique s'intéressera à l'examen de l'otorrée.

Est-ce qu'il s'agit d'une otorrée serreuse et auquel cas ça va être une otorrée incolore, inodore et fluide? Une otorrée muqueuse ou l'otorrée est gluante, incolore ou jaune clair? Une otorrée franchement purulente ou l'otorrée devient jaune ou verdâtre et dont l'odeur doit être précisée? Est-ce qu'elle est fade ou fétide? Et bien sûr, l'otorrée sanglante ou seulement teintée de sang. L'examen clinique du patient s'intéressera à l'examen du pavillon de l'oreille. Ce qui parle plus particulièrement de la présence ou l'absence de la douleur à la mobilisation du pavillon.

Qui pourrait nous expliquer l'existence d'une inflammation au niveau du conduit auditif externe et plus particulièrement comme étiologie otite externe diffuse. L'examen otoscopique examinera le conduit auditif externe à la recherche d'une inflammation ou d'un furoncle du conduit. L'examen de la membrane tympanique à la recherche d'une perforation tympanique.

Comme c'est le cas à ce moment là avec issue de sérosité. Ou bien dans le cas d'une otite moyenne aiguë perforée avec issue de liquide purulent. Les étiologies des otorrées vont être totalement différentes en fonction de leur nature.

Dans le cas des otorrées muqueuses ou purulentes, l'étiologie peut siéger au niveau de l'oreille externe ou au niveau de l'oreille moyenne. Au niveau de l'oreille externe, l'étiologie qu'on peut rencontrer est une otite externe. Qu'elle soit bactérienne ou mucosique avec une inflammation diffuse de la paroi du conduit auditif externe et la présence de sécrétion à son niveau.

L'existence d'un furoncle du conduit auditif externe peut justifier l'otorrée muqueuse ou purulente. Au niveau de l'oreille moyenne, on peut avoir comme étiologie d'otorrée muqueuse ou purulente, une otite moyenne aiguë perforée, comme c'est le cas sur cette photo du bas vers la gauche, c'est une otite moyenne aiguë collectée et perforée. Une otite moyenne chronique cholestéatomateuse avec des sécrétions purulentes fétides, comme c'est le cas dans cette photo du bas de la droite.

Ou un cancer de l'oreille moyenne qui est relativement beaucoup plus rare dans le cadre des étiologies des otorrées muqueuses ou purulentes. Dans le cadre des otorrées sanglantes, on retrouvera essentiellement les étiologies traumatiques au niveau du conduit auditif externe par une plaie qui peut être secondaire à l'usage des côtes ou tiges, par exemple. Une perforation traumatique du tympan, vous voyez ici avec des bords rectilignes, un hématome de la membrane tympanique.

Ils peuvent être d'origine infectieuse au niveau de l'oreille moyenne, tel que par exemple, les otites grippales avec flicènes qui vont, lors de leur rupture, donner un saignement à l'attente d'une otorrée sanglante ou dans le cadre des otites moyennes chroniques, plus particulièrement cholestéatomateuse avec polypes qui saignent souvent secondaire à des processus

inflammatoires. Dans le cadre de ces otorées sanguinolentes, on peut trouver comme étiologie les tumeurs du conduit auditif externe ou de l'oreille moyenne de façon beaucoup plus rare. Devant une otorée aqueuse, c'est-à-dire représentée par un liquide clair, inodore.

Ces otorées aqueuses peuvent être secondaires à une issue du liquide céphalo-rachidien par le conduit auditif externe. À ce moment-là, on va parler des autolichorées qui peuvent être d'origine traumatique dans le cadre des traumatismes crâniens avec fractures du rocher, faisant communiquer les espaces sous-arachnoïdiens avec les cavités de l'oreille moyenne et le conduit auditif externe ou d'étiologie tumorale au niveau de la base du crâne et qui font communiquer la base du crâne avec les cavités de l'oreille moyenne et le conduit auditif externe, justifiant l'existence du liquide céphalo-rachidien au niveau du conduit auditif externe. Donc, en conclusion, devant une otorée.

La conduite à tenir va être différente en fonction de sa nature. Est-ce qu'elle est séreuse, muqueuse, purulente ou sanguinolente? Les données anamnestiques et l'examen clinique centré sur l'examen otoscopique va le plus souvent nous permettre de différencier les différentes étiologies de ce symptôme assez fréquent en situation clinique habituelle. Et je vous remercie.

Bien, bonjour. Après avoir vu dans le cadre des cours de séméiologie ORL, les surdités, les otalgies, les otorées, nous allons maintenant traiter un cours en relation avec les vertiges. Alors que les objectifs du cours, c'est définir un vertige.

C'est quoi un vertige? Deuxièmement, savoir mener une anamnèse devant un vertige. Troisièmement, savoir faire un examen clinique devant un vertige. Quatrièmement, éliminer un faux vertige.

Cinquièmement, différencier entre vertiges périphériques et vertiges centrales. Et sixièmement, citer les étiologies d'un vertige périphérique et d'un vertige central. Alors, c'est quoi la définition d'un vertige? Le vertige est une sensation erronée du déplacement du corps par rapport à l'espace ou de l'espace par rapport au corps.

C'est en fait une illusion de mouvement que va vous rapporter le patient et qui n'est pas réel. C'est une sensation erronée. C'est un symptôme qui s'accompagne d'un cortège clinique déroutant parce que le patient souvent va présenter des nausées, vomissements, pâleurs, tachycardie, ce qui risque d'orienter le diagnostic vers un autre appareil digestif ou cardiaque.

Mais l'étude séméiologique du vertige va se fixer comme objectif principal d'essayer d'approcher le diagnostic étiologique de ce vertige. Pour traiter ce cours, nous avons adopté le plan suivant. Après une introduction, nous allons parler de l'anamnèse devant un vertige.

L'examen clinique d'un patient vertigineux. Quelles sont les diagnostics différentiels, c'est à dire éliminer ce qui est un faux vertige et enfin les étiologies des vertiges. L'anamnèse d'un patient vertigineux va s'acquiescer de son âge et de son sexe.

Les étiologies sont différentes, le plus souvent en fonction de l'âge. Les antécédents de maladies ou de chirurgie de l'oreille moyenne ou de l'oreille interne. Les antécédents traumatiques.

Et à ce moment là, il faut rechercher une notion d'un traumatisme crânien, même s'il est ancien. Ou de maladies neurologiques pour laquelle le patient est suivi chez un neurologue. L'anamnèse s'intéressera aussi au caractère sémiologique du vertige.

À savoir la date et le mode du début de ces symptômes. Quelles sont ces circonstances d'apparition? Est ce que c'est un vertige qui apparaît au mouvement lorsque le patient change de position? Ou bien c'est un vertige permanent, quelle que soit la situation du patient, par exemple. Son intensité, est ce que c'est un vertige qui permet quand même au patient à réaliser ses activités habituelles? Ou bien qui ne lui permet plus de pouvoir bouger? La direction de sensation de déplacement, c'est à dire, est ce que c'est un vertige qui donne une illusion de rotation? Ou bien c'est un vertige qui donne une illusion de déplacement vertical ou horizontal? Quelle est la durée de la crise vertigineuse? Est ce que c'est une crise qui dure moins d'une minute? Est ce qu'il dure quelques heures ou bien il dure depuis plusieurs jours? Et puis son évolution dans le temps pour s'acquérir essentiellement de la notion de périodicité d'apparition de cette symptomatologie vertigineuse.

L'anamnèse doit s'acquérir aussi des signes accompagnateurs. Les signes neurovégétatifs tels que la nausée, vomissement, pâleur, tachycardie, etc. n'ont aucune orientation, c'est à dire qu'ils ne nous permettent pas d'orienter notre diagnostic.

Il existe dans la majorité des vertiges qui sont en rapport avec une atteinte du système neurovégétatif. Les signes accompagnateurs à rechercher sont particulièrement représentés par les signes otologiques, plus particulièrement l'existence d'une otorhée, d'une surdité, des acouphènes ou des signes neurologiques, à savoir l'existence ou pas de céphalées et de déficits neurologiques chez le patient qu'il sent à type d'un déficit moteur sensitif ou sensoriel. L'examen clinique sera centré sur l'appareil auditif et l'appareil vestibulaire, à savoir pour l'appareil auditif un examen otoscopique avec la réalisation d'une acoumétrie instrumentale ou diapason recherchant l'existence d'une surdité.

Le système vestibulaire sera examiné à la recherche d'un nystagmus. Et c'est donc qu'on va dire déjà c'est quoi un nystagmus. Le nystagmus, ce sont des mouvements saccadés simultanés des deux yeux avec une phase rapide et une phase lente.

Une phase rapide et une phase lente. Il faut savoir que le sens du nystagmus est le sens de la phase rapide. Et donc, ce nystagmus sera recherché de façon spontanée, c'est à dire qu'on va essayer de regarder les yeux du patient sous lunettes grossissantes.

Et on va voir est-ce qu'il y a des mouvements saccadés simultanés des deux yeux. Si on ne le retrouve pas, on essaiera de le provoquer en mobilisant la tête du patient. La présence du

nystagmus est synonyme d'un vertige bien entendu.

Ensuite, on réalisera un examen vestibulaire à la recherche de Sindoramborg qui va nous permettre de rechercher la diviation segmentaire du corps vers un côté ou vers l'autre. Surtout lorsqu'on réalise aussi l'épreuve de piétinement yeux fermés, mains tendues en avant. Après l'examen audio auditif et l'examen vestibulaire, on va réaliser un examen neurologique et des paires crâniennes à la recherche d'un déficit neurologique moteur au sensitif.

À la recherche d'un syndrome cérébelleux et surtout à la recherche d'une atteinte des différentes autres paires crâniennes et qui peut nous expliquer de l'existence d'une lésion centrale. Enfin, on réalisera un examen général somatique. Avec la mesure particulière de la tension artérielle.

Avant d'entrer dans le diagnostic étiologique des vertiges, nous allons parler des diagnostics différentiels, plus particulièrement de ce qui est faux vertige. Ce sont des vertiges qui apparaissent lorsque le patient est mis en situation de hauteur. C'est une sensation vertigineuse et pas un vrai vertige.

Les vertiges psychogènes, plus particulier lorsque le patient sent un problème de claustrophobie ou lorsqu'ils sont mis en situation angoissante, ils sentent qu'ils ont une perturbation type vertige. Alors que c'est pas vrai, c'est pas un vertige, c'est pas un vertige vrai. Un vertige circulatoire dans le cadre de l'hypotension orthostatique.

Lorsque les patients passent d'une position assise à la position debout, leur tension artérielle chute de façon brutale. Ils sentent qu'ils ont un trouble de l'équilibre. Ce n'est pas un vertige, c'est un faux vertige.

Ou bien dans le cadre des vertiges métaboliques, dans le cadre des poglicémies, par exemple, où les patients ont des sensations vertigineuses, mais que ce n'est pas un vrai vertige. Les deux types de vertiges sur lesquels on va se focaliser maintenant, après avoir bien sûr fait l'examen et après avoir éliminé ce qui est faux vertige. Ce sont les vertiges d'origine périphérique et les vertiges d'origine centrale.

Et comment, bien sûr, différencier entre ces deux grandes situations, parce que c'est assez important de différencier ces différentes situations. Alors comment différencier entre ces deux types de vertiges? C'est en s'intéressant à le sens de la phase lente du nystagmus et le sens de la déviation segmentaire. Lorsque le sens de la déviation segmentaire et la phase lente du nystagmus vont dans le même sens.

À ce moment là, on va parler d'un syndrome harmonieux en faveur d'un vertige périphérique, c'est à dire d'une atteinte vestibulaire ou d'une erreur vestibulaire. Lorsque la déviation segmentaire et la phase lente du nystagmus sont des sens différents. On parlera d'un syndrome désharmonieux et à ce moment là, en faveur d'un vertige central.

Et bien entendu, ce n'est plus des lésions vestibulaires ou d'une erreur vestibulaire, mais par contre une atteinte des centres et des voies centrales du vestibulaire. Est-ce que la paraclinique a une place dans la prise en charge sémiologique du vertige? Il sera focalisé sur le bilan auditif par la réalisation de l'audiométrie tonale liminaire de l'impédance métrie des potentiels évoqués auditifs. Un bilan vestibulaire centré sur la vidéonystagmographie, c'est à dire la visualisation via un enregistrement vidéo du nystagmus dans différentes situations.

Et sur d'autres examens paracliniques en fonction de l'orientation diagnostique. Et en l'occurrence, on parlera essentiellement de l'imagerie représentée ici dans le cadre de l'exploration des vertiges sur la tomодensitométrie et la résonance magnétique nucléaire. Alors quelles sont maintenant les étiologies des vertiges? On va les scinder en deux.

Les vertiges périphériques peuvent être secondaires à des causes endolabyrinthiques, c'est à dire à l'intérieur du vestibule. Dans ce cadre là, on retrouve des vertiges paroxystiques positionnels bénins. Ce sont des vertiges qui vont apparaître au changement de position.

La maladie de Menière que nous avons déjà vu dans le cadre de la surdité, qui peut s'accompagner aussi d'une perturbation vertigineuse. L'anivrite vestibulaire, les labyrinthies et bien sûr, les lésions traumatiques du rocher passant à travers le labyrinthe. Ce vertige périphérique peut être secondaire à une atteinte du nerf vestibulaire dans le cadre des causes rétrolabyrinthiques et en chef de file, on retrouve le neurinome de l'acoustique.

Les étiologies des vertiges centraux peuvent être d'origine tumorale dans le cadre du tumeur de la force cérébrale postérieure ou dans le cadre des tumeurs purement cérébelleuses. Peuvent être secondaires à la pathologie vasculaire dans le cadre des ischémies bulbares ou des ischémies cérébelleuses. Dans le cadre de la pathologie infectieuse, dans le cadre aussi des abcès cérébelleux ou plus rarement dans le cadre de la pathologie toxique centrale secondaire à l'usage d'un produit entraînant des vertiges d'origine centrale.

En conclusion, devant un vertige, l'anamnèse est très importante. Elle va nous permettre de s'acquérir d'un certain nombre d'éléments qui vont d'emblée orienter le diagnostic étiologique du vertige et surtout d'éliminer ce qui n'est pas vertige, c'est à dire ce qui est faux vertige. Cette anamnèse sera complétée par un examen clinique complet essentiellement neurologique pour éliminer tout ce qui est central.

Centré sur un examen otologique et vestibulaire pour associer ce vertige à une origine au niveau de l'appareil audio vestibulaire. Et bien sûr, ne pas oublier l'examen général qui parfois peut retrouver une hypotension orthostatique expliquant l'existence d'un faux vertige. On fera appel à des examens paracliniques en fonction des situations pour orienter le diagnostic.

Et cette anamnèse, cet examen clinique et ce bilan paraclinique nous permet d'emblée de différencier entre ce qui est vertige périphérique d'origine vestibulaire et nerveuse que du vertige

central qui est dû à une atteinte purement centrale. Et bien sûr, quand on va différencier entre vertige périphérique et centrale, à ce moment là, on pourra se focaliser sur les différentes idéologies du vertige. Je vous remercie.